

Un étudiant autiste dans votre résidence / équipe de santé étudiante

Pour le personnel des résidences universitaires, des halls et les infirmiers de santé étudiante — soutenir un étudiant autiste (environ 18 à 25 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un étudiant se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. Les résidences et les services de santé étudiants — partagés, bruyants, imprévisibles et riches en nouvelles exigences — font partie des environnements les plus difficiles pour un jeune adulte autiste, et beaucoup **frappent un mur** (burnout, anxiété, crise) lors de leur première année. Vous êtes peut-être le premier professionnel sécurisant qu'ils rencontrent. Des soins prévisibles, à faible charge sensorielle, littéraux et un accès rapide au bon soutien peuvent véritablement changer une vie.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Négligence de soi, ne mange pas/ne dort pas, reste enfermé	Burnout autistique résultant de la charge cumulative universitaire
Évite la cuisine commune, l'étage social, le cabinet médical	Barrières sensorielles/sociales — ce n'est pas de la paresse ou un problème d'« adaptation »
Ne signale la maladie ou la douleur que lorsqu'elle est sévère	Différences d' intéroception ; « ne pas dire » ≠ « ne pas souffrir »
Deviens silencieux, se retire pendant des jours	Shutdown/récupération sous l'effet de la surcharge
Identifié seulement maintenant, en pleine crise	Un point d'identification tardive courant

Essayez ceci

- **Soyez prévisible et réduisez la charge sensorielle** — une pièce calme, un contact nommé, des informations écrites, un avertissement préalable.
- **Offrez des options écrites/en ligne** pour les rendez-vous ; autorisez la présence d'un accompagnateur et l'utilisation d'un kit sensoriel.
- **Interrogez proactivement sur la santé mentale, le sommeil, l'alimentation et la sécurité** — de manière littérale et séparée.
- **Connaissez les points de repère** — service du handicap, bien-être, mentorat, lignes d'urgence — et allez-y *avec* eux.
- **Traitez une crise comme un besoin non satisfait**, et non comme une « incapacité à gérer l'indépendance » ; une réduction de la charge est une étape légitime.

Évitez ceci

- Évaluations bruyantes, lumineuses ou basées sur la surprise ; informations vagues ou uniquement verbales.
- Assimiler le silence, la négligence de soi ou un affect plat à un « choix de ne pas s'engager ».

- Réduire la situation à un « stress d'étudiant typique » et passer à côté d'un burnout ou d'une première identification.

Quand demander plus de soutien

Soyez attentif au **burnout autistique** (épuisement, perte de compétences, tolérance réduite) et à la **suicidalité** — dépistez et interrogez directement. Orientez vers le service du handicap/bien-être, le mentorat et les communautés d'étudiants autistes. Une réduction temporaire de la charge ou une interruption d'études est une étape de récupération alignée sur les preuves.

Si l'étudiant est une femme

Les femmes identifiées tardivement camouflent intensément ; un étudiant « sociable et performant » peut s'effondrer en privé. Prenez au sérieux le retrait et la réduction de la tolérance, quelle que soit l'apparence extérieure.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — le **Guide pour les praticiens et professionnels de santé** (Parties 3.4 & 4), le **Guide pour la famille** (Partie 4) et le brief **Monotropisme**. Utilisez le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic**. Adaptez-le à l'individu.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024, interoception); AASPIRE AHAT (autismandhealth.org). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.